Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROJETO DE APOIO AS REDES REGIONAIS DE ATENÇÃO A SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARAS

Nº Carta Consulta: 61202
Mutuário: Estado de São Paulo
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 113.000.000,00
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 230.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 03
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 04
2.7. PROJETO/COMPONENTES 05
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 07
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 08
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 08
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 09
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 10
3. FINANCIAMENTO 10
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 10
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 10
4. EXECUÇÃO 10
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 10
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 11
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 11
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 11
5. RISCOS 13
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 13
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 13
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 14
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 14
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 14
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 14
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 15

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Estado de São Paulo está situado no sudeste brasileiro, ocupando 3% do território nacional e abriga uma população de 44.411.238 milhões de habitantes, o que representa aproximadamente 21% da população do país (IBGE, 2022). Esses números fazem de São Paulo a terceira unidade administrativa mais populosa da América do Sul.

São Paulo também se destaca economicamente, contribuindo com mais de 32,2% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. O estado abriga o maior parque industrial do país e é líder na produção econômica, refletindo em um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0 ,806 (IBGE, 2022), o segundo mais alto do Brasil, superado apenas pelo Distrito Federal. No entanto, São Paulo enfrenta desafios significativos relacionados às desigualdades socioeconômicas regionais e concentração de pobreza, especialmente em áreas como o Vale do Ribeira, Vale do Paraíba e Itapeva, onde o IDH pode ser tão baixo quanto 0,639 (Ribeirão Branco).

A evolução do Sistema Único de Saúde (SUS) em São Paulo nas últimas três décadas demonstra avanços consideráveis na ampliação do acesso da população aos serviços de saúde, tanto na atenção primária quanto em serviços de maior complexidade. No entanto, como em outras unidades federativas, as disparidades regionais e infraestruturais ainda impactam os resultados globais, criando barreiras significativas no acesso aos serviços de saúde.

A Carta-Consulta em questão prioriza o tema da regionalização, inovação e tecnologia em saúde, buscando uma mudança de paradigma que promova um "governo único para cidadão único". Isso implica na democratização do acesso à informação e no desenvolvimento e prestação de serviços públicos integrados, com foco no cidadão, em contraposição a um foco exclusivo no sistema de saúde.

O enfrentamento das Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT) emergiu como uma das principais prioridades da saúde pública no século XXI, representando cerca de 75% de todas as causas de morte no Brasil. Em São Paulo, as DANT continuam a ser as principais causas de óbito, com doenças do aparelho circulatório, neoplasias, doenças respiratórias e diabetes destacando-se como as mais prevalentes e custosas para o sistema de saúde.

As doenças do aparelho circulatório são responsáveis por aproximadamente 28,8% dos óbitos em São Paulo, seguidas por neoplasias (18 ,6%) e doenças respiratórias (12,8%) (IBGE, 2022). As causas externas, como lesões e violências, também são significativas, representando 7,3% dos óbitos e mostrando uma tendência de redução nas últimas décadas.

A morbidade das doenças crônicas, refletida nas internações pelo SUS, destaca as doenças do aparelho circulatório, respiratório e as neoplasias como as principais causas de ocupação de leitos hospitalares em São Paulo. A análise dos anexos (Anexo II e III) revela a magnitude dessas condições crônicas na demanda por serviços de saúde, evidenciando a necessidade de estratégias eficazes de gestão e prevenção.

São Paulo possui a maior capacidade instalada vinculada ao SUS no Brasil, com um sistema de saúde composto por 3.354 Unidades Básicas de Saúde, 559 hospitais, 1.849 ambulatórios de especialidade, 411 unidades de pronto socorro e 584 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Essa infraestrutura diversificada é complementada pelos 47 Hospitais de Ensino (HE) certificados e contratualizados pelo SUS, que desempenham um papel crucial na educação médica e na prestação de cuidados especializados.

Apesar da ampla rede de serviços de saúde, persistem desafios significativos na organização e integração dos cuidados, especialmente entre os diferentes níveis assistenciais. A falta de padronização nos protocolos de atendimento e a fragmentação dos serviços hospitalares são obstáculos que comprometem a eficiência do sistema, aumentando a incidência de internações desnecessárias e a dificuldade no acompanhamento de casos crônicos.

A distribuição desigual das unidades de saúde em São Paulo reflete uma histórica concentração nos centros econômicos desenvolvidos, o que requer investimentos específicos para equacionar as disparidades regionais de acesso aos serviços de saúde de média e alta complexidade. A estratégia de regionalização e expansão de serviços como leitos de média complexidade, cuidados domiciliares e paliativos é fundamental para otimizar a rede hospitalar e atender às demandas crescentes por cuidados de saúde especializados.

São Paulo enfrenta desafios complexos e urgentes na gestão de sua saúde pública, demandando políticas integradas e inovadoras que não apenas fortaleçam a infraestrutura existente, mas também promovam a equidade no acesso aos serviços de saúde. A implementação eficaz dessas estratégias melhorará os resultados de saúde da população e contribuirá para o desenvolvimento sustentável e inclusivo do estado.

Referências:

Anexo I: Tabela de Mortalidade por causa principal nos últimos 6 anos.

Anexo II e III: Tabelas de morbidade e internações SUS segundo causa principal nos últimos 12 anos em São Paulo.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

O Projeto de Apoio às Redes Regionais de Atenção à Saúde do Estado de São Paulo ? ARAS SP é um conjunto de investimentos que visa o fortalecimento da ação do SUS em São Paulo, prevendo a melhoria na oferta de serviços essenciais para as regiões mais pobres e vulneráveis do Estado, nas quais ainda persistem problemas de acesso e qualidade do SUS. O Projeto a luz da experiência exitosa do Programa Saúde em Ação visa dar continuidade as ações de consolidação e fortalecimento das redes regionais de atenção a saúde - RRAS, expandindo para outras áreas do estado que não foram beneficiadas na primeira operação de crédito do BID, investimentos para a articulação e coordenação do cuidado a partir da integração entre a Atenção Primária e a Atenção Especializada.

Será utilizado como eixo central do Projeto ARAS SP, o processo de Regionalização no Estado de São Paulo, que será o ponto de partida para pensarmos a redefinição do perfil assistencial das unidades que compõem as redes de atenção à saúde, para dessa forma, equalizar o acesso e qualidade dos serviços no Estado de São Paulo e organizar a atenção à saude de forma racionalizada e eficiente. É importante ressaltar que o Estado está fazendo um grande trabalho com os gestores nas regiões, com escuta qualificada, o que garantiu um processo de regionalização representativo e que têm corroborado com os dados aqui apresentados. Este investimento na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) que inclui as RRAS de 01 a 06 (especialmente na RRAS 6) e nas RRAS 8 e RRAS 12, representará uma resposta do Estado às necessidades e dificuldades destas regiões. Haverá a construção dos dois novos hospitais nas RRAS 8 e RRAS 12 e um grande investimento de reforma, adequação e inovação do parque tecnológico nas unidades da Região Metropolitana de São Paulo, onde concentram-se as maiores desigualdades sociais no Estado, além do apoio para a elaboração dos Planos Regionais Integrados, melhorando a organização da rede e a governança regional, que serão fundamentais para o sucesso da regionalização no Estado, ampliando o acesso e qualificando a assistência. O projeto também busca contribuir para a agenda de inovação em saúde, a partir do financiamento de novas tecnologias da estratégia de Saúde Digital, com o investimento em infraestrutura em tecnologia da informação e modernização dos equipamentos nos 15 Hospitais da administração direta contemplados no presente projeto, bem como modernização e aquisição de servidores, storage e segurança de dados no nível central da SES, possibilitando a recepção das novas tecnologias, incluindo a telemedicina e informatização das unidades para utilização de ferramentas de gestão.

Com a adequação na estrutura das Unidades existentes e atualização de um parque tecnológico já obsoleto e ineficiente, assim como a construção de 2 novos Hospitais, o resultado almejado é uma ampliação no acesso à diagnósticos e tratamentos as principais causas de morbimortalidade identificadas nas diversas regiões do estado. E com as ações propostas para o apoio à gestão, busca-se a constituição de regiões potentes, com uma governança eficiente na avaliação e monitoramento dos contratos e prestação de serviços, com vistas a um planejamento integral que traga autonomia para a região e linhas de cuidado / protocolos efetivamente implantados para uma assistência oportuna e qualificada. O projeto também busca contribuir para a agenda de inovação por meio do financiamento de novas tecnologias em saúde, o desenvolvimento de uma aplicação para o monitoramento de acordos de gestão estadual-municipais e a promoção ao uso de novas tecnologias, especialmente a telemedicina.

As ações propostas trazem, em si, um componente de sustentabilidade após o projeto, tendo em vista que, são impulsionadoras, pois são ações de fortalecimento de políticas públicas estabelecidas, e que, portanto, podem ser executadas com fontes de recurso próprias, uma vez superados os custos iniciais de implantação.

No Plano Plurianual (PPA) de 2024-2027, o Programa 930: Atendimento Integrado e Regionalizado no SUS no Estado de São Paulo, contempla as entregas necessárias à garantia do acesso mais rápido do usuário a uma Rede Integrada de Serviços dentro de sua região. Desenvolvendo e implantando políticas públicas robustas e prestando todo o apoio técnico e financeiro aos municípios do estado, com o objetivo de fortalecer a rede de governança e ampliar os serviços à toda população.

Todas as ações financiadas pelo projeto serão informadas e pactuadas em CIR (Comissão Intergestores Regionais), compostas pelos Secretários Municipais de Saúde e representantes da administração regional da SES, em funcionamento em todas as regiões de saúde.

Outro ponto que contribuirá para a sustentabilidade das ações é o investimento no fortalecimento da gestão pública. Estão previstos a aquisição de novas tecnologias e o desenvolvimento de sistemas de informação, que se tornarão um ganho perene para a Administração Pública Estadual. Da mesma forma, a contratação de consultorias e capacitações para os servidores públicos estaduais e municipais permitirá a transferência de conhecimentos, habilidades e competências que serão incorporados ao repertório organizacional mesmo com o encerramento do financiamento.

Após a conclusão do projeto, a Secretaria de Estado da Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde, ficarão responsáveis pela continuidade e pelo aporte dos recursos necessários para o bom funcionamento dos serviços de saúde criados e das atividades de regulação e controle das RRAS; visto que a execução do projeto visa, principalmente, o fortalecimento institucional das regionais de saúde , de maneira a solidificar as suas bases de atuação futura.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O SUS é o maior e mais duradouro programa social do país e ampliou enormemente o acesso da população, aos serviços de saúde, embora com resultados diferentes em cada região, mesmo enfrentando um contexto de dificuldades, relacionadas com a realidade econômica e social do país, com o baixo poder aquisitivo da população e com recursos insuficientes ao sistema. Ainda mais se considerarmos a demanda sempre crescente, por uma ampliação tecnológica e assistencial.

Contudo o SUS ainda carece de aperfeiçoamentos estruturais e de gestão para garantir o atendimento universal e integral da população, conforme as diretrizes constitucionais. O Estado de São Paulo, que possui a maior e mais complexa rede de saúde do Brasil, apresenta as melhores condições para que o SUS se aproxime cada vez mais de seus principais objetivos. Para tanto, necessita aperfeiçoar as suas redes de atenção, regulação, integração de serviços e realização de investimentos para corrigir déficits regionais porventura existentes.

O aperfeiçoamento e o sucesso no desenvolvimento do SUS/SP será exemplo para todo o país e trará o reconhecimento de que o atendimento das necessidades de saúde dos cidadãos é fundamental, não apenas para beneficiar a qualidade de vida individual, mas também como insumo imprescindível para o desenvolvimento sustentável da Nação.

Ao longo das últimas décadas, o estado de São Paulo vem atuando fortemente no aperfeiçoamento do SUS/SP, ampliando e modernizando sua rede de serviços próprios e transferindo recursos para os Municípios investirem em seus equipamentos de saúde. Além de investimentos na infraestrutura, vem aprimorando os mecanismos de gestão, articuladamente com os gestores municipais. Estas iniciativas e ações estão traduzidas no Plano Plurianual ? PPA 2024-2027 ? Nos Programas tabulados no anexo XXVIII.

As ações propostas no Programa de apoio à regionalização, fortalecimento da gestão e impulso à transformação digital na Saúde do estado de São Paulo foram baseadas no diagnóstico situacional realizado para embasar o Plano Estadual de Saúde 2024-2027.

Valor Financeiro da Contrapartida: US$ 113.000.000,00, relativas a construção e investimentos em infraestrutura de duas novas unidades hospitalares no Estado em Birigui e Itapetininga. No caso dos processos de gestão e regionalização, o estado está desenvolvendo, a partir de recursos próprios e em parceria com projeto do PROADI SUS, diagnóstico nos territórios que serão utilizados aqui como referência. Os gastos estão em conformidade com as resoluções da COFIEX.

USD 1,00 = R$ 5,4

Valores de venda do dólar em 03 de julho de 2024.

2. Projeto

2.1. Título
PROJETO DE APOIO AS REDES REGIONAIS DE ATENÇÃO A SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARAS

2.2. Título Abreviado
PROJETO ARAS SP

2.3. Mutuário
Estado de São Paulo

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVO GERAL:

Contribuir para melhorar as condições de saúde da população do Estado de São Paulo, por meio da estratégia de regionalização iniciada em 2009 e visando a consolidação das Redes de Atenção à Saúde (RAS) e do fortalecimento das capacidades de gestão da saúde por parte do estado. Os principais beneficiários do Projeto serão aproximadamente 27 milhões de habitantes SUS dependentes (60% da população geral) para o cuidado à saúde que serão impactadas pelo fortalecimento das RAS, nas RRAS, resultante da implementação de sistemas de apoio à gestão e às linhas de cuidado a partir da análise de situação de saúde, investimentos na infraestrutura nos territórios mais vulneráveis através de melhorias nas unidades de saúde estaduais.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1)Fortalecer a ação do SUS em São Paulo, prevendo a melhorias na oferta de serviços essenciais, no fortalecimento da rede regional de serviços de saúde, na articulação e coordenação do cuidado a partir da integração entre a Atenção Primária e a Atenção Especializada, por meio de três componentes (sempre com ênfase na regionalização do cuidado à saúde):

2)Utilizar como estratégias o apoio ao processo de regionalização no Estado de São Paulo, que será o ponto de partida para pensarmos a redefinição do perfil assistencial das unidades que compõem as redes de atenção à saúde;

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Número de Hospitais estratégicos da Administração Direta reformados e/ou ampliados	Numero Absoluto	Unidade	0,00	12,00
Número de Hospitais da Administração direta contemplados com a renovação do parque tecnologico	Número Absoluto	Unidade	0,00	15,00
Número de Hospitais estratégicos administrados por OSS reformados e/ou ampliados	Numero absoluto	Unidade	0,00	18,00
Número de Hospitais Administrados po OSS contemplados com a renovação do parque tecnologico	Numero Absoluto	Unidade	0,00	22,00
Número de oficinas de regionalização nas RRAS contempladas	Numero Absoluto	Unidade	0,00	36,00
Número de novos hospitais construídos no Estado de São Paulo.	Numero Absoluto	Unidade	0,00	2,00
Número de Unidades beneficiadas com a adequação/ ampliação da infraestrutura para saúde digital (15 Hospitais + 01 Datacenter SES	Numero Absoluto	Unidade	0,00	16,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - C1: APOIO AOS PROCESSOS DE GESTÃO COM ÊNFASE NA REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE	**9.000.000,00**
S - S.1.2IMPLANTAÇÃO DE NOVOS MODELOS ASSISTENCIAIS	7.500.000,00
P - Implantação das Linhas de Cuidado Prioritárias no processo de regionalização	2.500.000,00
P - Formação de multiplicadores para cursos em Gestão da Clínica	2.500.000,00
P - Modelos de governança inovadores	2.500.000,00
S - GESTÃO DE REDES E GOVERNANÇA	1.500.000,00
P - Oficinas para Gestores para discussão dos modelos de governança propositivos e resolutivos	1.500.000,00
C - C.2INFRAESTRUTURA E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO	**185.000.000,00**
S - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS ESTADUAIS	185.000.000,00
P - Reformas das Unidades gerenciadas por OSS	36.924.519,71
P - REformas das UNidades da Administração Direta	59.512.962,96
P - Atualização do Parque Tecnológico de Unidades gerenciadas por OSS	50.565.752,72
P - Atualização do Parque Tecnologico das Unidades Estaduais da Administração Direta	37.996.764,61
C - COMPONENTE 3: INOVAÇÃO DIGITAL - SAÚDE DIGITAL	**30.000.000,00**
S - MELHORIA DA TECNOLGIA EM SAÚDE	30.000.000,00
P - Infraestrutura de TI para Hospitais da Administração Direta	20.000.000,00
P - Infra estrutura para o Datacenter no nivel central da Secretaria de Estado da Saúde	10.000.000,00
C - C.4GESTÃO DO PROJETO	**6.000.000,00**
S - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO	6.000.000,00
P - UGP implantada	6.000.000,00
Total dos Componentes	**230.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - C1: APOIO AOS PROCESSOS DE GESTÃO COM ÊNFASE NA REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE

Este componente visa apoiar a melhoria da capacidade da SES em seu papel estratégico, indutor e gerencial para a operação eficiente das RAS em São Paulo. Para os Processos de Apoio à Gestão Estadual para o processo de Regionalização das RRAS serão realizadas consultorias, contratos, capacitações.

S - S.1.2IMPLANTAÇÃO DE NOVOS MODELOS ASSISTENCIAIS

Este subcomponente tem como produto realizar consultorias para Implantação das Linhas de Cuidado Prioritárias no processo de regionalização e promover parcerias com universidades para formação de multiplicadores para cursos em Gestão da Clínica.

P - Implantação das Linhas de Cuidado Prioritárias no processo de regionalização

Este subcomponente tem como produto realizar consultorias para Implantação das Linhas de Cuidado Prioritárias no processo de regionalização e promover parcerias com universidades para formação de multiplicadores para cursos em Gestão da Clínica

P - Formação de multiplicadores para cursos em Gestão da Clínica

Parcerias com Universidades para formação de multiplicadores para cursos em Gestão da Clínica

P - Modelos de governança inovadores

Serão realizados estudos nas macro regiões para identificação de fragilidades e potencialidades nos modelos atuais de governança regional e para a definição de modelos que atendam a todas as especificidades das Macro regiões de Saúde, tendo o estado o papel estratégico indutor e coordenador efetivo deste processo.

S - GESTÃO DE REDES E GOVERNANÇA
Este subcomponente tem como produto o desenvolvimento de oficinas do processo de regionalização do SUS SP e o fortalecimento dos atores para realização do diagnóstico situacional estadual.

P - Oficinas para Gestores para discussão dos modelos de governança propositivos e resolutivos
Realização de Oficinas Macro regionais para discussão do Plano Regional Integrado, da Programação Assistencial e para a construção do Pacto pela Saúde de São Paulo.

C - C.2INFRAESTRUTURA E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO
Este componente deverá priorizar as reformas e as inovações do parque tecnológico das unidades da SES envolvidas no projeto ARAS; RRAS 1 a 6, RRAS 8 e RRAS 12.

S.2.1Melhorias na Infraestrutura da Rede de Serviços Estaduais
P.2.1.1Reforma dos Hospitais da Administração Direta
P.2.1.2Reforma dos Hospitais sob gestão das OSS
P.2.1.3Equipagem dos Hospitais da Administração Direta
P.2.1.4Equipagem dos Hospitais sob gestão das OSS

S - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS ESTADUAIS
Este subcomponente tem como produto realizar a Reforma dos Hospitais da Administração Direta, Reforma dos Hospitais de OSS, Equipagem dos Hospitais da Administração Direta e Equipagem dos Hospitais da Administração Direta.

P - Reformas das Unidades gerenciadas por OSS
Reformas de 18 Unidades Hospitalares próprias estaduais sob gerenciamento de OSS.

P - REformas das UNidades da Administração Direta
Reformas de 12 Hospitais estaduais da Administração Direta.

P - Atualização do Parque Tecnológico de Unidades gerenciadas por OSS
Atualização do Parque Tecnológico de Unidades gerenciadas por OSS

P - Atualização do Parque Tecnologico das Unidades Estaduais da Administração Direta
Atualização do Parque Tecnológico das Unidades Estaduais da Administração Direta

C - COMPONENTE 3: INOVAÇÃO DIGITAL - SAÚDE DIGITAL
S.C.3.1 Melhoria da Tecnolgia em Saúde
Este subcomponente tem como produto prover as Unidades Hospitalares, da Administração Direta com equipamentos de TI permitindo a inovação na área de saúde digital. Os investimentos neste componente III do projeto atingem o valor de US$ 30 milhões de dólares.

S - MELHORIA DA TECNOLGIA EM SAÚDE
Este subcomponente tem como produto prover as Unidades Hospitalares, da Administração Direta, bem como do datacenter da Secretaria de estado da Saúde, com infraestrutura para TI permitindo a inovação na área de saúde digital.

P - Infraestrutura de TI para Hospitais da Administração Direta
Prover de Infraestrutura em TI os Hospitais da Administração Direta contemplados neste projeto, para a promoção ao uso de novas tecnologias, como telemedicina, prontuário eletrônico e outros.

P - Infra estrutura para o Datacenter no nivel central da Secretaria de Estado da Saúde
Prover de infra estrutura de TI (Servidores, Storage, Segurança da Informação, o Datacenter da Secretaria de estado da Saúde - Nível Central, permitindo a capacidade para a absorção de novas tecnologias na saúde digital.

C - C.4GESTÃO DO PROJETO

Implantação de Unidade de Coordenação do Programa para a gestão dos projetos e monitoramento das obras

S - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO
Este subcomponente tem como produto implantação de Unidade de Coordenação do Projeto para a gestão dos componentes .

P - UGP implantada
A UGP deverá apoiar a SES na execução efetiva do Projeto, responsável pelo gerenciamento efetivo das atividades planejadas e do monitoramento dos resultados , além de suprir as despesas operacionais como passagens, hospedagens, etc. .

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**96.437.482,67**	**41,93**
P- Reformas das Unidades gerenciadas por OSS	Numero Absoluto	18,00	36.924.519,71	16,05
P- REformas das UNidades da Administração Direta	Numero Absoluto	12,00	59.512.962,96	25,88
Bens	-	-	**118.562.517,33**	**51,55**
P- Atualização do Parque Tecnológico de Unidades gerenciadas por OSS	Numero Absoluto	22,00	50.565.752,72	21,99
P- Atualização do Parque Tecnologico das Unidades Estaduais da Administração Direta	Numero Absoluto	15,00	37.996.764,61	16,52
P- Infraestrutura de TI para Hospitais da Administração Direta	Numero Absoluto	15,00	20.000.000,00	8,70
P- Infra estrutura para o Datacenter no nivel central da Secretaria de Estado da Saúde	Numero Absoluto	1,00	10.000.000,00	4,35
Consultoria	-	-	**5.000.000,00**	**2,17**
P- Implantação das Linhas de Cuidado Prioritárias no processo de regionalização	Numero Absoluto	10,00	2.500.000,00	1,09
P- Modelos de governança inovadores	Numero absoluto	18,00	2.500.000,00	1,09
Capacitação e Treinamento	-	-	**2.500.000,00**	**1,09**
P- Formação de multiplicadores para cursos em Gestão da Clínica	Numero Absoluto	2.000,00	2.500.000,00	1,09
Outros	-	-	**7.500.000,00**	**3,26**
P- Oficinas para Gestores para discussão dos modelos de governança propositivos e resolutivos	Numero Absoluto	100,00	1.500.000,00	0,65
P- UGP implantada	Numero Absoluto	1,00	6.000.000,00	2,61
Total Geral	-	-	**230.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

O Programa Saúde em Ação, cofinanciado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento ? BID, iniciado em 2014 com término em 2021, evidenciou a necessidade urgente de investimentos no setor de tecnologia, buscando a inovação nas práticas gerenciais e assistenciais no SUS.

A concepção do Programa foi uma resposta ao perfil epidemiológico do estado, em que as três principais causas de mortalidade na última década foram doenças cardiovasculares, neoplasias e patologias do sistema respiratório, com o fortalecimento das Redes de Atenção a Saúde em 5 regiões priorizadas. A não efetividade dos atendimentos na atenção básica, sobretudo no que diz respeito às doenças crônicas não transmissíveis e saúde materno infantil, parece ter tido impacto relevante neste perfil. Houve crescimento na proporção de mortes prematuras por diabetes mellitus no estado e, em algumas regiões, a prevalência de hipertensos, assim como um aumento significativo na mortalidade infantil.

O Fortalecimento da gestão na SES também foi contemplado com ações específicas, como o desenvolvimento dos Planos Diretores da Assistência Farmacêutica e da Educação Permanente, oferecendo estudos com vasto diagnóstico dos temas e diretrizes a serem perseguidas para o melhor desempenho nestas áreas. E um estudo para a Elaboração do Diagnóstico e Avaliação do Estágio de Desenvolvimento das Redes Regionais da Atenção à Saúde nas Regiões Priorizadas pelo programa.

Com a continuidade do Programa Saúde em ação, o processo de apoio à gestão, deverá envolver oficinas de trabalho, consultorias e treinamentos, especialmente voltados à Gestão Regional, ou ao que chamamos de Regionalização na saúde. Vale lembrar o movimento da regionalização feito até aqui no Estado de São Paulo:

Em 2023, o processo de regionalização entra novamente como prioridade na discussão da organização da assistência no estado, na perspectiva de alinhamento com as discussões nacionais. Nesse sentido, foram realizadas oficinas em cada macrorregião de saúde (RRAS), no intuito de identificar as prioridades sanitárias, em cada região de saúde, e construir estratégias para superação dos problemas identificados, construindo acordos entre os gestores municipais e a gestão estadual, e superar a fragmentação na gestão da assistência à saúde no estado.

O primeiro ciclo de oficinas ocorreu no período de maio a outubro de 2023, em todo o estado, com a participação de todos os municípios, Departamentos Regionais de Saúde, COSEMS e nível central da SES. Nas oficinas macrorregionais, o estado de São Paulo traz como uma inovação, a inclusão dos prestadores de serviços nas discussões, de modo a ampliar a discussão entre os todos os atores que influenciam na dinâmica da provisão de serviços de ações de saúde. Além dos problemas de saúde e de acesso, foi incentivada a discussão da sustentabilidade técnica e financeira de Hospitais de Pequeno Porte (HPP), bem como a possibilidade de ampliação e/ou mudança de perfil assistencial de estabelecimentos de saúde, de acordo com as especificidades locais.

O segundo ciclo de oficinas, foi realizado no início de 2024, com o objetivo de trazer a devolutiva das regiões de saúde, dos problemas processados e das estratégias construídas para superar os problemas identificados. Além disso, a partir da publicação da ?Tabela SUS Paulista?, como proposta de cofinanciamento estadual para hospitais filantrópicos, as oficinas reuniram gestores e prestadores de saúde, na construção de propostas de alocação dos novos recursos, a partir dos problemas identificados pelos atores, no primeiro ciclo de oficinas e discussões regionais.

A reativação dos Comitês Executivos de Governança das Redes de Atenção à Saúde nas macroregiões de saúde do estado (RRAS), é um primeiro passo para a institucionalização da regionalização no estado, na construção de ciclos permanentes de planejamento e monitoramento em cada macrorregião, de modo a balizar a alocação de recursos dos 3 entes e orientar a organização das Redes de Atenção à Saúde.

Outro ponto de discussão foi a adequação e melhoria na infra estrutura da rede estadual de serviços para o melhor atendimento da demanda SUS. Neste sentido foi realizado um estudo identificando as reformas necessárias em algumas Unidades, assim como a aquisição e substituição de equipamentos necessários ao funcionamento ideal das mesmas, para que trabalhem em sua capacidade máxima de atendimento e/ou até mesmo promovam uma ampliação.

Neste mesmo período também foi celebrado um Termo de Cooperação mutuo entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria de Gestão e Governo Digital de São Paulo, que teve por objeto a conjugação de esforços entre os partícipes para a efetiva execução do Componente 4 ? Saúde Digital do Projeto São Paulo Mais Digital, nos produtos em que a SES será beneficiária.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado de São Paulo ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i) CONDIÇÕES FINANCEIRAS

Prazo de desembolso: 60 meses (5 anos);

Prazo de carência: 60 meses (5 anos);

Prazo de amortização: 228 meses (19 anos);

Prazo total: 288 meses (24 anos);

Periodicidade da amortização: Semestral;

Taxa de juros: SOFR (5,39% em 03/07/2024) + spread variável (atualmente 0,8%) + Funding margin (atualmente 0,4%);

Demais encargos do financiamento:

- Comissão de Crédito: Até 0,75% ao ano sobre o saldo não desembolsado do Empréstimo.

- Despesas de Inspeção e Supervisão: até 1% do valor do empréstimo, dividido pelo número de semestres compreendidos no prazo original de desembolsos

(ii) NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E A OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO

(a) Justificar a necessidade e a opção por financiamento externo em detrimento de financiamento interno:

A busca por financiamento externo para o projeto decorre de várias considerações estratégicas e econômicas. Em primeiro lugar, o custo dos empréstimos nacionais é mais alto do que os empréstimos internacionais, conforme exposto adiante na comparação entre agentes financeiros. Ainda, algumas entidades nacionais, como o BNDES, exigem um índice mínimo de nacionalização dos itens adquiridos com recursos do financiamento, o que pode não ser viável no presente projeto, que apresenta em um de seus componentes a aquisição de aparelhos de diagnóstico e tratamento de alta tecnologia que muitas vezes não tem produção nacional. Além disso, a captação de recursos de instituições internacionais apresenta-se como uma alternativa valiosa, uma vez que tais entidades oferecem não apenas recursos financeiros, mas também expertise técnica e padrões rigorosos de governança, socioambientais e de desempenho. de modo a conferir uma credibilidade adicional ao projeto, reforçando seu compromisso com elevados padrões de qualidade e responsabilidade socioambiental. Portanto, a opção por financiamento externo, especialmente de entidades internacionais de renome, se mostra como uma estratégia sólida e vantajosa para impulsionar o êxito e a sustentabilidade do projeto, além de se configurar como uma alternativa mais barata.

(b) Justificar a opção pelo agente financeiro escolhido:

A escolha do BID como agente financeiro para o decorre de uma série de fatores, dentre eles, o fato de apresentar as taxas mais baixas, conforme demonstrativo juntado nos anexos. O BID conta também a seu favor com uma experiência positiva em projetos na área de saúde no Brasil. Ainda, o Estado de São Paulo tem um bom histórico de relacionamento com o BID, contando com seu apoio em diversos projetos nas mais diversas áreas. Por já ter essa experiência prévia com o agente financeiro, o proponente tem conhecimento das normas de licitação do Banco bem como de outros aspectos operacionais de forma a facilitar o relacionamento do executor com a instituição financeira quanto a estes termos.

(c) Comparar as condições financeiras do agente financeiro escolhido em relação a outros financiadores externos/internos, utilizando os mesmos parâmetros do item (i) acima:

Na decisão pela fonte de financiamento do projeto, foram analisadas alternativas de financiamentos nacionais e internacionais. Verifica-se que o BID oferece encargos financeiros substancialmente abaixo dos bancos nacionais. Segue, para efeitos comparativos, a descrição das características dos financiamentos dos principais bancos:

BIRD: SOFR + Spread Variável (dependente do prazo médio do financiamento e país). Para um prazo médio de 15 a 18 anos o spread vigente é de 1,65% a.a. Encargos: Comissão de Financiamento de 0,25%; Comissão de compromisso sob o saldo não desembolsado de 0 ,25% a.a.;

BID: SOFR + Margem de Captação BID + Margem para empréstimos, atualmente totalizando SOFR + 1,2% a.a. (prazo médio máximo de 15,25). Encargos: Comissão de compromisso de até 0,75% a.a. sob o saldo não desembolsado;

NDB: SOFR + Spread Variável, dependente do prazo médio do financiamento. Para um prazo médio de 15 a 18 anos o spread mais recente disponível é de 1,6% a.a.. Encargos: Comissão de Financiamento de 0,25%; Comissão de compromisso de 0,25% a.a. sob o saldo não desembolsado;

CAF: SOFR + Spread Variável, dependente do prazo médio do financiamento. Para prazo total, até 18 anos, o spread mais recente é de 2, 0% a.a., sendo que nos primeiros 8 anos seria de 1,9%a.a. Encargos: Comissão de Financiamento de 0,85% do valor do financiamento; Comissão de compromisso de 0,35% a.a. do saldo não desembolsado; Gastos de avaliação: US$ 50.000,00.

Quanto aos financiadores internos, com aval da União, a carência é limitada a 12 meses e não há possibilidade de ressarcimento de despesas realizadas antes da assinatura do contrato de financiamento. Adicionalmente, ainda que os contratos com instituições nacionais exijam o cumprimento de critérios socioambientais, não há apoio técnico como aquele oferecido pelos grandes organismos multilaterais.

Além disso, o custo de operações internas aumentou devido a publicação da Portaria 808, de 26/07/2023, que estabeleceu cobrança de 0, 5% do valor do financiamento a título de contrapartida ao aval da União.

- O BNDES oferece ao Estado de São Paulo TLP +1,4%, que atualmente equivalem 11,46 % a.a.;

- O BB oferece operações de no máximo 12 anos e propõe encargos financeiros de CDI+1,63% a.a. (atualmente 12,03% a.a.).

Por fim, apresentamos no anexo um quadro resumo para comparação das condições financeiras e prazos oferecidos pelos diversos agentes financeiros nacionais e internacionais.

Consta nos anexos uma tabela comparando as taxas de juros e condições das diversas instituições financeiras.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O PROJETO ARAS SÃO PAULO, por sua natureza de Projeto de apoio aos processos de gestão e de investimentos em reformas e atualização do parque tecnológico das unidades hospitalares nas RRAS da RMSP (RRAS de 01 a 06), RRAS 8 e RRAS 12, terá impacto social positivo para os usuários do SUS, tendo em vista a capacitação das equipes locais e a ampliação da oferta de serviços.

O atendimento a esta população se dará com atenção e consideração de suas especificidades culturais. Para o risco de privilégio indevido na seleção de beneficiários, serão construídas ferramentas com informações transparentes e objetivas, que focalizam o público a ser beneficiado, conforme critérios técnicos legalmente estabelecidos.

Público-alvo:

?Secretarias de Saúde, Estadual e Municipais, que poderão contar com recursos para estruturação e fortalecimento de sua capacidade gestora;

?Os serviços de saúde sob gestão estadual, que contarão com investimentos para melhorar sua capacidade produtiva, a qualidade dos atendimentos, a organização e potencialização da oferta de serviços à população;

?Os trabalhadores do Sistema Único de Saúde do estado de São Paulo, que poderão contar com maior qualificação e organização do processo de trabalho.

Beneficiários:

?A população SUS dependente do estado de São Paulo, com a melhoria do acesso e da qualidade das ações e serviços de saúde.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	113.000.000,00	1,00	113.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	230.000.000,00	1,00	230.000.000,00
Total:			343.000.000,00		343.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

A execução estará a cargo da Secretaria de Estado da Saúde ? SES/SP. A SES/SP é o gestor estadual do SUS/SP. Na coordenação e gerenciamento da execução do Programa a SES/SP utilizará, além dos recursos humanos e materiais próprios, os serviços de empresa de consultoria contratada especificamente para programas financiados.

A Secretaria de Saúde foi criada com a denominação de Secretaria da Saúde Pública e da Assistência Social pelo Decreto nº 17.339 de 28/6/1947, que desvinculou os assuntos referentes à área de saúde dos de ensino. A denominação atual de Secretaria de Estado da Saúde foi estabelecida pelo Decreto n.º 52.182, de 16/7/1969.

No atual desenho do SUS/SP, resultado das diretrizes nacionais do sistema, a Secretaria de Estado da Saúde ? SES tem a responsabilidade geral de formulação e coordenação da política do SUS no Estado.

As funções da SES podem ser resumidas em 5 dimensões:

1.Manter a rede assistencial própria do Governo do Estado

São os serviços próprios estaduais de saúde, hospitalares ou ambulatoriais da administração direta, indireta (fundações e autarquias) e de Organizações Sociais de Saúde - OSS, que são referência regional, especializada ou de alta complexidade do sistema. Saliente-se que esta rede inclui grandes hospitais universitários, como os Hospitais de Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo e da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - USP, da Faculdade de Medicina da Universidade de Campinas ? UNICAMP e da Faculdade de Medicina da Universidade Paulista ? UNESP, o Instituto do Coração ? INCOR/USP, Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia.

2.Gerir, planejar e regular a rede assistencial vinculada ao SUS

São os serviços de assistência médica de maior complexidade vinculados ao SUS, de caráter estadual ou regional, que permanecem sob gestão da SES (rede de Santas Casas e hospitais filantrópicos, Hospitais de Ensino, serviços especializados de oncologia, nefrologia, hemorrede, entre outros).

3.Manter os órgãos estaduais de apoio às ações da Secretaria de Saúde

São os institutos e fundações com funções específicas na saúde estadual, como a Fundação para o Remédio Popular (FURP), Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo, Fundação Oncocentro (FOSP), Instituto Emílio Ribas, o Centro de Referência e Treinamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis ? DST/Aids, os institutos de pesquisa (Instituto Butantan, Adolfo Lutz, Instituto de Saúde, Instituto Pasteur, Instituto Lauro de Souza Lima).

4. Realizar, coordenar e planejar as ações de saúde coletiva no Estado

Estabelecer as normas estaduais e realizar ações de vigilância epidemiológica e sanitária, de combate aos vetores e outras ações de interesse para a saúde coletiva, por meio de seus órgãos centrais e regionais, como o Centro de Vigilância Epidemiológica ? CVE e o Centro de Vigilância Sanitária ? CVS.

5. Desenvolver ações de supervisão, capacitação, acompanhamento, avaliação e apoio aos sistemas de saúde municipais

Por meio de seus órgãos centrais e regionais (17 Departamentos Regionais de Saúde ? DRS) a SES participa dos colegiados regionais de saúde (em conjunto com os representantes municipais), prestando auxílio aos sistemas municipais de saúde e formulando estratégias de aperfeiçoamento do sistema.

A atual estrutura da SES/SP foi estabelecida por meio dos Decretos nº 49.343, de 24/01/2005, nº 51.433, de 28/12/2006, nº 51.434, de 28/12/2006 e nº 51.435, de 28/12/2006, que alteraram principalmente os órgãos centrais (coordenadorias) e reduziram seus órgãos regionais (Anexo XXXIV).

Atualmente a Secretaria conta com aproximadamente 70 mil funcionários ativos, presentes em todas as regiões do Estado de São Paulo e disponibilizará os servidores necessários para a execução das atividades técnicas deste projeto, inclusive com dedicação exclusiva.

A matriz de responsabilidade está no anexo XXXIV.

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo			
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - C1: APOIO AOS PROCESSOS DE GESTÃO COM ÊNFASE NA REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE	**9.000.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**		
S - S.1.2IMPLANTAÇÃO DE NOVOS MODELOS ASSISTENCIAIS	7.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
P - Implantação das Linhas de Cuidado Prioritárias no processo de regionalização	2.500.000,00	0,00	500.000,00		
P - Formação de multiplicadores para cursos em Gestão da Clínica	2.500.000,00	0,00	500.000,00		
P - Modelos de governança inovadores	2.500.000,00	0,00	500.000,00		
S - GESTÃO DE REDES E GOVERNANÇA	1.500.000,00	0,00	300.000,00		
P - Oficinas para Gestores para discussão dos modelos de governança propositivos e resolutivos	1.500.000,00	0,00	300.000,00		
C - C.2INFRAESTRUTURA E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO	**185.000.000,00**	**0,00**	**37.000.000,00**		
S - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS ESTADUAIS	185.000.000,00	0,00	37.000.000,00		
P - Reformas das Unidades gerenciadas por OSS	36.924.519,71	0,00	7.384.903,94		
P - REformas das UNidades da Administração Direta	59.512.962,96	0,00	11.902.592,60		
P - Atualização do Parque Tecnológico de Unidades gerenciadas por OSS	50.565.752,72	0,00	10.113.150,54		
P - Atualização do Parque Tecnologico das Unidades Estaduais da Administração Direta	37.996.764,61	0,00	7.599.352,92		
C - COMPONENTE 3: INOVAÇÃO DIGITAL - SAÚDE DIGITAL	**30.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**		
S - MELHORIA DA TECNOLGIA EM SAÚDE	30.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
P - Infraestrutura de TI para Hospitais da Administração Direta	20.000.000,00	0,00	4.000.000,00		
P - Infra estrutura para o Datacenter no nivel central da Secretaria de Estado da Saúde	10.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
C - C.4GESTÃO DO PROJETO	**6.000.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**		
S - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO	6.000.000,00	0,00	1.200.000,00		
P - UGP implantada	6.000.000,00	0,00	1.200.000,00		
Total	**0,00**	**0,00**	**46.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - C1: APOIO AOS PROCESSOS DE GESTÃO COM ÊNFASE NA REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE		**0,00**	**2.250.000,00**		
S - S.1.2IMPLANTAÇÃO DE NOVOS MODELOS ASSISTENCIAIS		0,00	1.875.000,00		
P - Implantação das Linhas de Cuidado Prioritárias no processo de regionalização		0,00	625.000,00		
P - Formação de multiplicadores para cursos em Gestão da Clínica		0,00	625.000,00		
P - Modelos de governança inovadores		0,00	625.000,00		
S - GESTÃO DE REDES E GOVERNANÇA		0,00	375.000,00		
P - Oficinas para Gestores para discussão dos modelos de governança propositivos e resolutivos		0,00	375.000,00		
C - C.2INFRAESTRUTURA E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO		**0,00**	**46.249.999,99**		
S - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS ESTADUAIS		0,00	46.249.999,99		
P - Reformas das Unidades gerenciadas por OSS		0,00	9.231.129,92		
P - REformas das UNidades da Administração Direta		0,00	14.878.240,74		
P - Atualização do Parque Tecnológico de Unidades gerenciadas por OSS		0,00	12.641.438,18		
P - Atualização do Parque Tecnologico das Unidades Estaduais da Administração Direta		0,00	9.499.191,15		
C - COMPONENTE 3: INOVAÇÃO DIGITAL - SAÚDE DIGITAL		**0,00**	**7.500.000,00**		
S - MELHORIA DA TECNOLGIA EM SAÚDE		0,00	7.500.000,00		
P - Infraestrutura de TI para Hospitais da Administração Direta		0,00	5.000.000,00		
P - Infra estrutura para o Datacenter no nivel central da Secretaria de Estado da Saúde		0,00	2.500.000,00		
C - C.4GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**1.500.000,00**		
S - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO		0,00	1.500.000,00		
P - UGP implantada		0,00	1.500.000,00		
Total	**0,00**	**0,00**	**57.499.999,99**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - C1: APOIO AOS PROCESSOS DE GESTÃO COM ÊNFASE NA REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE		**0,00**	**2.700.000,00**		
S - S.1.2IMPLANTAÇÃO DE NOVOS MODELOS ASSISTENCIAIS		0,00	2.250.000,00		
P - Implantação das Linhas de Cuidado Prioritárias no processo de regionalização		0,00	750.000,00		
P - Formação de multiplicadores para cursos em Gestão da Clínica		0,00	750.000,00		
P - Modelos de governança inovadores		0,00	750.000,00		
S - GESTÃO DE REDES E GOVERNANÇA		0,00	450.000,00		
P - Oficinas para Gestores para discussão dos modelos de governança propositivos e resolutivos		0,00	450.000,00		
C - C.2INFRAESTRUTURA E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO		**0,00**	**55.500.000,01**		
S - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS ESTADUAIS		0,00	55.500.000,01		
P - Reformas das Unidades gerenciadas por OSS		0,00	11.077.355,92		
P - REformas das UNidades da Administração Direta		0,00	17.853.888,89		
P - Atualização do Parque Tecnológico de Unidades gerenciadas por OSS		0,00	15.169.725,82		
P - Atualização do Parque Tecnologico das Unidades Estaduais da Administração Direta		0,00	11.399.029,38		
C - COMPONENTE 3: INOVAÇÃO DIGITAL - SAÚDE DIGITAL		**0,00**	**9.000.000,00**		
S - MELHORIA DA TECNOLGIA EM SAÚDE		0,00	9.000.000,00		
P - Infraestrutura de TI para Hospitais da Administração Direta		0,00	6.000.000,00		
P - Infra estrutura para o Datacenter no nivel central da Secretaria de Estado da Saúde		0,00	3.000.000,00		
C - C.4GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**1.800.000,00**		
S - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO		0,00	1.800.000,00		
P - UGP implantada		0,00	1.800.000,00		
Total	**0,00**	**0,00**	**69.000.000,01**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - C1: APOIO AOS PROCESSOS DE GESTÃO COM ÊNFASE NA REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE		**0,00**	**1.350.000,00**		
S - S.1.2IMPLANTAÇÃO DE NOVOS MODELOS ASSISTENCIAIS		0,00	1.125.000,00		
P - Implantação das Linhas de Cuidado Prioritárias no processo de regionalização		0,00	375.000,00		
P - Formação de multiplicadores para cursos em Gestão da Clínica		0,00	375.000,00		
P - Modelos de governança inovadores		0,00	375.000,00		
S - GESTÃO DE REDES E GOVERNANÇA		0,00	225.000,00		
P - Oficinas para Gestores para discussão dos modelos de governança propositivos e resolutivos		0,00	225.000,00		
C - C.2INFRAESTRUTURA E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO		**0,00**	**27.750.000,01**		
S - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS ESTADUAIS		0,00	27.750.000,01		
P - Reformas das Unidades gerenciadas por OSS		0,00	5.538.677,96		
P - REformas das UNidades da Administração Direta		0,00	8.926.944,44		
P - Atualização do Parque Tecnológico de Unidades gerenciadas por OSS		0,00	7.584.862,91		
P - Atualização do Parque Tecnologico das Unidades Estaduais da Administração Direta		0,00	5.699.514,70		
C - COMPONENTE 3: INOVAÇÃO DIGITAL - SAÚDE DIGITAL		**0,00**	**4.500.000,00**		

S - MELHORIA DA TECNOLGIA EM SAÚDE		0,00	4.500.000,00		
P - Infraestrutura de TI para Hospitais da Administração Direta		0,00	3.000.000,00		
P - Infra estrutura para o Datacenter no nivel central da Secretaria de Estado da Saúde		0,00	1.500.000,00		
C - C.4GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**900.000,00**		
S - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO		0,00	900.000,00		
P - UGP implantada		0,00	900.000,00		
Total	**0,00**	**0,00**	**34.500.000,01**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - C1: APOIO AOS PROCESSOS DE GESTÃO COM ÊNFASE NA REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE		**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**9.000.000,00**
S - S.1.2IMPLANTAÇÃO DE NOVOS MODELOS ASSISTENCIAIS		0,00	750.000,00	0,00	7.500.000,00
P - Implantação das Linhas de Cuidado Prioritárias no processo de regionalização		0,00	250.000,00	0,00	2.500.000,00
P - Formação de multiplicadores para cursos em Gestão da Clínica		0,00	250.000,00	0,00	2.500.000,00
P - Modelos de governança inovadores		0,00	250.000,00	0,00	2.500.000,00
S - GESTÃO DE REDES E GOVERNANÇA		0,00	150.000,00	0,00	1.500.000,00
P - Oficinas para Gestores para discussão dos modelos de governança propositivos e resolutivos		0,00	150.000,00	0,00	1.500.000,00
C - C.2INFRAESTRUTURA E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO		**0,00**	**18.499.999,99**	**0,00**	**185.000.000,00**
S - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS ESTADUAIS		0,00	18.499.999,99	0,00	185.000.000,00
P - Reformas das Unidades gerenciadas por OSS		0,00	3.692.451,97	0,00	36.924.519,71
P - REformas das UNidades da Administração Direta		0,00	5.951.296,29	0,00	59.512.962,96
P - Atualização do Parque Tecnológico de Unidades gerenciadas por OSS		0,00	5.056.575,27	0,00	50.565.752,72
P - Atualização do Parque Tecnologico das Unidades Estaduais da Administração Direta		0,00	3.799.676,46	0,00	37.996.764,61
C - COMPONENTE 3: INOVAÇÃO DIGITAL - SAÚDE DIGITAL		**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**30.000.000,00**
S - MELHORIA DA TECNOLGIA EM SAÚDE		0,00	3.000.000,00	0,00	30.000.000,00
P - Infraestrutura de TI para Hospitais da Administração Direta		0,00	2.000.000,00	0,00	20.000.000,00
P - Infra estrutura para o Datacenter no nivel central da Secretaria de Estado da Saúde		0,00	1.000.000,00	0,00	10.000.000,00
C - C.4GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**
S - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO		0,00	600.000,00	0,00	6.000.000,00
P - UGP implantada		0,00	600.000,00	0,00	6.000.000,00
Total	**230.000.000,00**	**0,00**	**22.999.999,99**	**0,00**	**230.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Atos Legais

O arcabouço legal para execução do Projeto está em implementação, com a elaboração do projeto será apresentado a instância estadual e municípios contemplados para execução do mesmo.

Uma vez que o Projeto esteja em andamento, poderão ser celebrados: termos de cooperação com outras secretarias de Estado; termos de adesão com municípios; convênios com municípios; contratações de consultoria; contratações de instituições bancárias para operacionalização das transferências de renda.

Riscos

As principais contratações estão vinculadas aos produtos listados nos componentes do projeto. Será necessária contratação de bens, consultorias e serviços. Está prevista, ainda, a contratação de profissionais para a viabilização da execução das ações, especialmente no interior, em interface com os municípios.

Os principais riscos estariam associados ao atraso na elaboração dos documentos preparatórios de licitação, tais como: plano de aquisição, termos de referências, projetos executivos, estimativas de custos, editais. Tais riscos serão mitigados com o recurso da experiência dos gestores do programa em contrato de financiamento internacional, com o apoio especializado em aquisições para auxiliar os órgãos participantes, monitoramento e controle em todas as etapas de planejamento, licitação, contratação e conclusão, reuniões periódicas sobre o desempenho dos contratos, com sinalização de probabilidade de cumprimento e com elaboração de plano de ação para o cumprimento dos mesmos.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

As principais contratações estão vinculadas aos produtos listados nos componentes do projeto. Será necessária contratação de bens, consultorias e serviços. Está prevista, ainda, a contratação de profissionais para a viabilização da execução das ações, especialmente no interior, em interface com os municípios.

Os principais riscos estariam associados ao atraso na elaboração dos documentos preparatórios de licitação, tais como: plano de aquisição, termos de referências, projetos executivos, estimativas de custos, editais. Tais riscos serão mitigados com o recurso da experiência dos gestores do programa em contrato de financiamento internacional, com o apoio especializado em aquisições para auxiliar os órgãos participantes, monitoramento e controle em todas as etapas de planejamento, licitação, contratação e conclusão, reuniões periódicas sobre o desempenho dos contratos, com sinalização de probabilidade de cumprimento e com elaboração de plano de ação para o cumprimento dos mesmos.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Empreendimentos de infraestrutura, pela própria natureza e caráter sistêmico, podem provocar impactos no meio ambiente. No caso do Projeto ARAS, isto se aplica notadamente nos territórios onde aconterão as construções dos novos hospitais.

Ao mesmo tempo, ao buscar um futuro de qualidade para a população, a concepção do projeto implica a noção de sustentabilidade e a adoção de medidas de preservação do meio ambiente. Será adotado sistema alinhado com os padrões de desempenho previstos no Marco de Política Ambiental e Social (MPAS) do BID como alavanca para mitigação de riscos, melhor desempenho na execução dos projetos e melhores resultados ambientais e sociais, ao longo do ciclo de vida do projeto.

Para a variável ambiental, são especialmente relevantes as diretrizes relativas à avaliação e gestão de riscos e impactos sociais e ambientais e à conservação de

biodiversidade e gestão sustentável dos recursos naturais, de modo apropriado à natureza, objetivos, necessidades, escala, prazo e recursos do programa.

Serão incorporadas as melhores práticas internacionais trazidas pelo BID às especificidades relacionadas à produção de infraestrutura pelo Programa, observandoos

elementos do marco legal e regulatório nacional e estadual aplicáveis, tais como:

a)Política Nacional do Meio Ambiente: com objetivos e forma de aplicação definidos

na Lei Complementar no 140/2011, Lei no 6.938/1981, Decreto no 99.274/1990, Resolução no 237/1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e, no que respeita às penalidades aplicáveis às infrações ambientais, a Lei no 9.605, de 12/02/1998;

b)Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN no 4.945/2021: Dispõe sobre a Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC) e sobre as ações com vistas à sua efetividade para as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil;

As empresas contratadas para execução dos empreendimentos serão devidamente orientadas e fiscalizadas quanto ao cumprimento da legislação brasileira e paulista, bem como das salvaguardas ambientais do BID.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

O PROJETO ARAS SÃO PAULO, por sua natureza de Projeto de apoio aos processos de gestão e de investimentos em reformas e atualização do parque tecnológico das unidades hospitalares nas RRAS da RMSP (RRAS de 01 a 06), RRAS 8 e RRAS 12, terá impacto social positivo para os usuários do SUS, tendo em vista a capacitação das equipes locais e a ampliação da oferta de serviços. Não se visualiza, a priori, impacto social adverso ou relacionado a conflito de interesses entre a administração pública e comunidades locais. A implementação das ações do Programa passará por acompanhamento permanente pelos conselhos estaduais e municipais de políticas públicas e garantias de direitos, implicando gestores públicos, técnicos da área, sociedade civil e beneficiários diretos.

O PROJETO ARAS SÃO PAULO contemplará as comunidades tradicionais com a ampliação da oferta de serviços e leitos. O atendimento a esta população se dará com atenção e consideração de suas especificidades culturais. Para o risco de privilégio indevido na seleção de beneficiários, serão construídas ferramentas com informações transparentes e objetivas, que focalizam o público a ser beneficiado, conforme critérios técnicos legalmente estabelecidos.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN